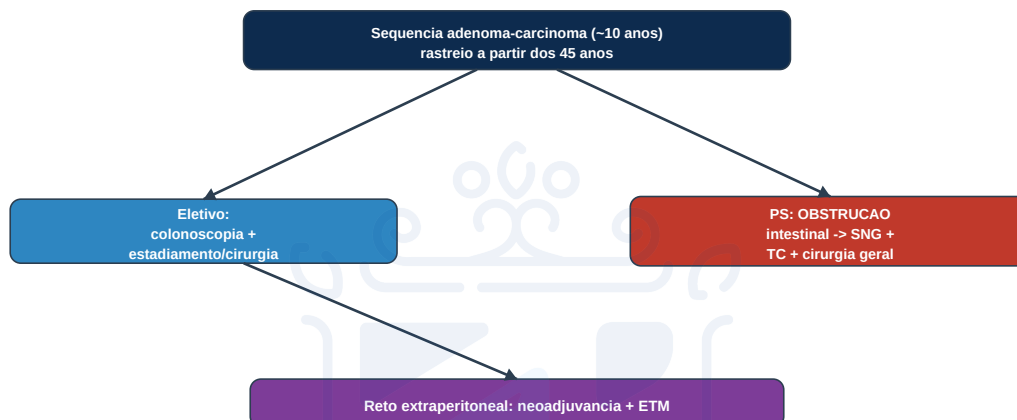


CÂNCER COLORRETAL — RASTREIO + OBSTRUÇÃO

FLUXOGRAMA — DO RASTREIO À EMERGÊNCIA

CCR — RASTREAR x APRESENTAÇÃO NO PS



FATORES DE RISCO E CARCINOGÊNESE

O QUE É

- Tumor mais comum do trato gastrointestinal; sequência adenoma-carcinoma leva ~10 anos
- Risco: idade, sedentarismo, dieta inadequada, tabagismo, etilismo, obesidade, diabetes
- Hereditários: PAF, polipose associada a MUTYH, síndrome de Lynch (HNPCC)
- Doença inflamatória intestinal (RCU, Crohn) e colite actínica (pós-radiação)
- Pólipos NEOPLÁSICOS (com displasia): adenoma tubular (melhor prognóstico) < tubuloviloso < viloso (pior); serrilhados (planos, difíceis); NÃO neoplásicos: hiperplásicos, hamartomas, inflamatórios

RASTREAMENTO

População	Estratégia
Risco médio (a partir de 45 anos)	Colonoscopia a cada 10 anos (padrão); ou TIF/sangue oculto anual; ou retossigmoidoscopia 5-10 anos ± TIF; ou colono-TC a cada 5 anos
Familiar de 1º grau com CCR	Iniciar aos 40 anos OU 10 anos antes da idade do caso índice — colonoscopia
PAF / Lynch / RCU / Crohn	Protocolos específicos (início mais precoce e intervalos menores)
Colono inviável (lesão intransponível)	Colonografia por TC (colonoscopia virtual) se preparo adequado

CLÍNICA POR LOCALIZAÇÃO / SINAIS DE ALARME

QUANDO SUSPEITAR

- Cólon DIREITO: anemia ferropriva, sangue oculto, massa palpável, sintomas tardios (lúmen amplo)
- Cólon ESQUERDO/reto: alteração do hábito intestinal, fezes afiladas, hematoquezia, obstrução (lúmen estreito)
- Sinais de alarme: sangramento, anemia inexplicada, emagrecimento, mudança do hábito após os 45 anos -> COLONOSCOPIA
- Reto: toque retal, sangramento vivo, tenesmo
- No PS, a apresentação mais comum é a OBSTRUÇÃO INTESTINAL

TRATAMENTO ONCOLÓGICO (VISÃO GERAL)

CÓLON x RETO

- Cólon (e reto intraperitoneal): ressecção com linfadenectomia (ligadura dos vasos na origem, ≥ 12 linfonodos)
- Reto EXTRAPERITONEAL (~até 7 cm da borda anal): excisão TOTAL do mesorreto (ETM); margem distal livre suficiente para R0
- Neoadjuvância (QT-RT) no reto: T3/T4, linfonodo+, tumores distais (preservar esfíncter), envolvimento da fáscia mesorretal
- Benefícios: downstaging, preservação esfíncteriana, menos recidiva local, resposta completa ('watch and wait'); TNT = QT sistêmica + RT
- Amputação abdominoperineal (Miles) + colostomia definitiva quando há acometimento do esfíncter/elevador do ânus

CCR NO PS — OBSTRUÇÃO

Rx MEDIDAS INICIAIS

Sonda nasogástrica nº 18 para descompressão
Hidratação venosa + analgesia + antiemético
Correção de distúrbios hidroeletrólíticos
Imagem: TC de abdome e pelve (padrão-ouro na obstrução)
Avaliação da cirurgia geral / transferência via SAMU; jejum

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com ____ (obstrução/hematoquezia/anemia/massa); duração ____; história prévia ____.
- Exame: distensão ____, sinais de estrangulamento ____, toque retal ____; sinais vitais completos.
- Condutas: SNG, hidratação, analgesia, correção hidroeletrólítica; TC de abdome/pelve ____.
- Solicito avaliação da cirurgia geral / transferência; fornecer exames e enfatizar alterações críticas.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

A partir de qual idade se recomenda iniciar o rastreamento do câncer colorretal na população de risco médio?

- A) 30 anos
- B) 45 anos
- C) 60 anos
- D) 70 anos
- E) Não há rastreamento

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual apresentação clínica é mais típica do câncer de cólon DIREITO?

- A) Obstrução intestinal precoce
- B) Anemia ferropriva e sangue oculto nas fezes
- C) Fezes afiladas
- D) Tenesmo
- E) Hematoquezia volumosa

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual o princípio oncológico da cirurgia do câncer de reto extraperitoneal?

- A) Ressecção segmentar simples sem linfadenectomia
- B) Excisão total do mesorreto (ETM)
- C) Apenas polipectomia
- D) Colostomia sem ressecção
- E) Radioterapia isolada curativa

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente chega ao PS com quadro de obstrução intestinal por provável neoplasia de cólon. Qual o exame de imagem de escolha?

- A) Colonoscopia de urgência
- B) Tomografia de abdome e pelve
- C) Enema opaco
- D) Ressonância de crânio
- E) Cintilografia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual tipo histológico de pólipos adenomatosos tem o pior prognóstico?

- A) Tubular
- B) Viloso
- C) Hiperplásico
- D) Hamartomatoso
- E) Inflamatório

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O rastreamento do CCR em risco médio inicia aos 45 anos (colonoscopia a cada 10 anos é o padrão; alternativas incluem TIF anual, retossigmoidoscopia e colono-TC). Familiares de 1º grau e síndromes hereditárias começam antes.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O cólon direito tem lúmen amplo e cursa com sintomas tardios: anemia ferropriva e sangue oculto são típicos. Já o cólon esquerdo/reto cursa com alteração do hábito, fezes afiladas e obstrução.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

No reto extraperitoneal, o princípio é a excisão total do mesorreto (ETM), que reduz a recidiva local; margem distal livre é suficiente para a ressecção R0.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na obstrução por provável neoplasia colônica, a TC de abdome e pelve é o exame de escolha; a colonoscopia é contraindicada na obstrução aguda completa.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O adenoma viloso tem o pior prognóstico (maior risco de displasia/malignização); o tubular é o de melhor prognóstico e o tubuloviloso, intermediário. Hiperplásicos/hamartomatosos/inflamatórios não têm displasia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico